

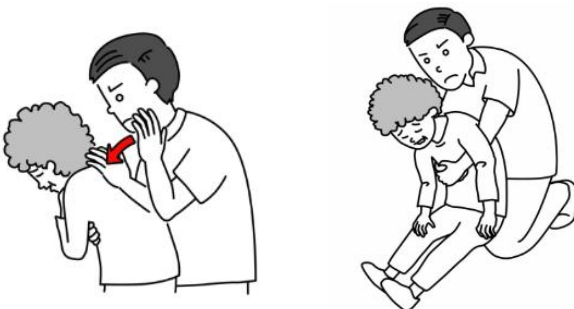
誤嚥・窒息予防対策

- ① 入院時、全患者に誤嚥・窒息リスクの評価を評価票に基づいて実施。
- ② 評価が5点以上の場合は、初回の食事摂取の状況を観察し評価する。

必要に応じて、看護計画を立案、医師へ ST 介入を提案する。

必要があれば食事形態も検討する。

特に、義歯があっていない、義歯が必要であるのに持っていない、歯が欠損している場合などは、食物を「丸ごと飲みこむリスク」が高い。このリスクを予防するには、主食は「二度炊き」、副食は「きざみ食」が望ましい。
- ③ 嚥下食や誤嚥リスクのある患者の食事レベルをあげる場合は、介助に携わる人が多い昼食からとする。
- ④ 誤嚥リスクが高い患者は、食事時カーテンを閉めない。
- ⑤ 転棟時や体調の変化（高熱・レベル低下等）がある場合には、誤嚥窒息の再評価を実施し手順にしたがって対応する。



窒息と判断した場合は、ハリーコールで人を集めるのと同時に、背部叩打法やハイムリック法、吸引などで救命する。